GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

PATIENT EDUCATION · GASTROENTEROLOGY

과민성 장 증후군 (IBS), 뇌-장 축의 올바른 이해

Rome IV 진단부터 저포드맵 식단, 아형별 표적 약물 치료까지 — 삶의 질을 회복하는 단계적 관리

IBS · Rome IV · Low-FODMAP · Targeted Pharmacotherapy

광교바른내과 소화기내과

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

먼저 결론 — 과민성 장 증후군, 이것만 기억하세요

흔하고, 암이 되지 않으며, 단계적으로 관리하면 좋아집니다

1

흔한 병입니다

어른 100명 중 **4~11명**이 겪습니다. 여성과 젊은 층에 더 많습니다.

혼자만의 문제가 아닙니다

2

장과 뇌의 연결이 예민해진 상태

내시경·피검사는 정상인데 배가 아프고 배변이 달라집니다. 장이 망가진 것이 아니라 **장과 뇌 사이 신호**가 예민해진 것입니다.

암·염증성 장질환으로 가지 않습니다

3

단계적으로 관리합니다

생활습관 → 식단 조절 → 증상에 맞는 약 순서로 접근하면 대부분 좋아집니다.

경고 증상은 먼저 확인

Tip · 예민한 성격 탓이 아닙니다. 신경의 감각이 달라진 것이라 자책할 필요가 없습니다.

근거 · Rome IV · ACG 진료지침 2021

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

이럴 때 과민성 장 증후군으로 진단합니다

로마 기준(Rome IV) — 증상의 기간·빈도·배변과의 관계를 봅니다

최근 3개월 동안

증상이 최근 3개월 동안 이어졌고, 처음 시작은 6개월 이상 전입니다.

일주일에 한 번 이상 복통

배가 아픈 날이 평균 주 1회 이상 되풀이됩니다.

배변과 관련된 통증

배변과 함께 아프거나 나아지고, 횟수나 변 모양이 달라집니다.

장 신경이 예민해진 상태

보통의 장 움직임이나 가스도 뇌가 심한 통증으로 느낍니다(내장 과민성).

Tip · 증상이 언제·얼마나 자주 생기는지 기록해 오시면 진단이 훨씬 정확해집니다.

근거 · Rome IV 진단 기준(2016)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

변 모양으로 나누는 네 가지 유형

유형에 따라 쓰는 약이 달라집니다 — 2주 동안 변 모양을 적어 오세요

변비형

딱딱한 변이 많고 배변 뒤에도 덜 본 느낌이 남습니다.
배가 더부룩합니다.

설사형

묽은 변이 많고 갑자기 급하게 화장실을 찾게 됩니다.

혼합형 · 미분류형

설사와 변비가 번갈아 오거나(혼합형), 어느 쪽도 뚜렷하지 않고 복통·가스가 주된 경우(미분류형)입니다.

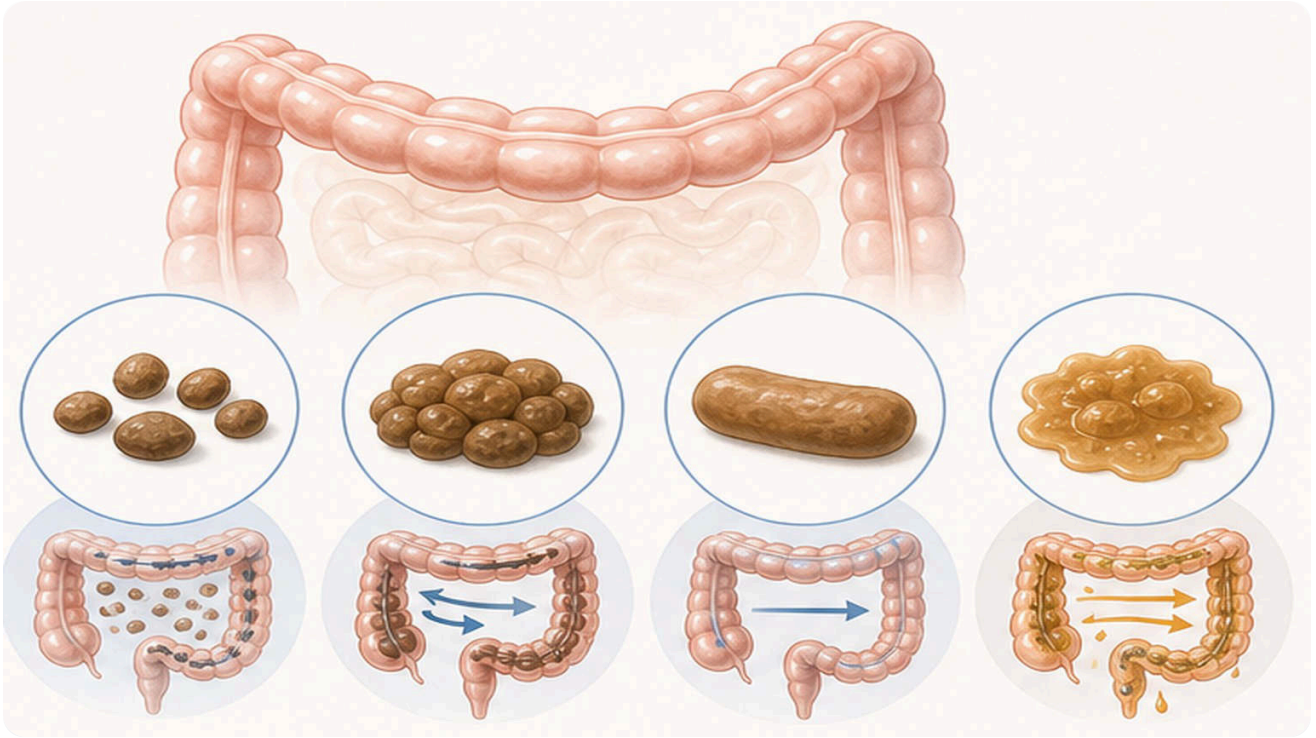


그림 · 변의 모양(딱딱함 ↔ 묽음)이 유형을 나누는 기준입니다(설명용 그림).

근거 · Rome IV 유형 분류 · 브리스톨 대변 척도

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

증상을 부르는 두 가지 방아쇠

병의 원인이 아니라 이미 예민한 장을 자극하는 계기입니다

스트레스

긴장하면 장과 뇌 사이 신호가 더 예민해집니다.

- 스트레스 호르몬이 장벽을 느슨하게 만듭니다
- 보통의 자극도 더 아프게 느껴집니다
- 규칙적 운동 · 충분한 잠 · 느린 호흡이 도움이 됩니다

vs

포드맵(FODMAP) 음식

소장에서 잘 흡수되지 않는 탄수화물입니다.

- 장으로 물을 끌어들여 설사를 부릅니다
- 대장 세균이 발효시켜 가스를 많이 만듭니다
- 밀·양파·마늘·우유·일부 과일에 많습니다(자세한 목록은 식사 안내문)

Tip · 두 가지 모두 '없애야 할 원인'이 아니라 '줄여 볼 계기'입니다.

근거 · Monash University 포드맵 · Mayer 2011

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

저포드맵 식단은 3단계로 짧게 해 봅니다

평생 참는 식단이 아니라 '나에게 맞지 않는 음식'을 찾는 과정입니다

1단계

빼 보기(elimination)

포드맵이 많은 음식을 빼고 식사 안내문의 대체 음식으로 식단을 짭니다. 오래 빼면 장 속 좋은 균이 줄어듭니다.

짧게 시험

2단계

다시 먹기 (reintroduction)

음식 종류를 하나씩 조금씩 다시 먹으며 무엇이 문제인지 찾습니다.

범인 찾기

3단계

나에게 맞추기

괜찮은 음식은 자유롭게, 문제 음식만 견딜 만큼 줄입니다.

다양하게 먹기

해 봐도 그대로면

다른 방법으로

식단이 원인이 아닐 수 있어 약물 또는 의사 상의가 필요합니다. 장-뇌 심리치료도 방법입니다.

진료에서 상의

Tip · 의사 확진 후 시작하고, 설사형은 수분 섭취를 유지하세요. 단계별 기간과 음식 목록은 식사 안내문을 따릅니다.

근거 · Monash University 저포드맵 3단계

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

약은 유형과 증상에 맞춰 고릅니다

약 이름보다 '어떤 증상을 겨냥하는가'가 중요합니다

변비형

변을 부드럽게 하고 복통을 함께 줄이는 쪽

장 분비를 늘리는 약

리나클로타이드 등 — 변비와 복통을 함께 덜어 줍니다. 설사가 부작용으로 올 수 있습니다.

장 경련을 푸는 약

배가 쥐어짜듯 아플 때 씁니다.

통증 신호를 누그러뜨리는 약

저용량 아미트립틸린 등 — 입 마름·변비 같은 부작용을 살핍니다.

설사형

장 속 환경을 바로잡고 설사를 줄이는 쪽

장 속 세균 환경을 바꾸는 약

리팍시민 — 몸에 거의 흡수되지 않는 항생제로 2주 먹고, 다시 나빠지면 한 번 더 쓸 수 있습니다.

설사를 멎게 하는 약

로페라마이드 — 변을 굳히지만 배 아픔은 줄이지 못합니다.

장 경련 · 통증 약

복통이 심할 때 함께 씁니다.

Tip · 나라마다 쓸 수 있는 약과 보험 적용이 다릅니다. 실제 처방은 진료에서 함께 정합니다.

근거 · ACG 진료지침 2021

대변 칼프로텍틴 — 장에 염증이 있는지 보는 검사

염증성 장질환과 구별할 때 씁니다 (단위 μg/g)

결과	뜻과 다음 단계
50 이하	염증성 장질환일 가능성이 낮습니다. 경고 증상이 없으면 과민성 장 증후군 쪽으로 판단하는 데 도움이 됩니다.
51~120	경계입니다. 소염진통제나 잠깐의 장염 때문일 수 있어 4~6주 뒤 다시 잽니다.
121~250	염증 가능성이 올라갑니다. 증상과 함께 보고 담당 의사가 대장내시경 등 추가 검사를 정합니다.
250 초과	장 염증 가능성이 높습니다. 감염·복용 약·증상을 함께 확인하고, 담당 의사가 재검·전문의 진료·내시경 필요성을 정합니다.

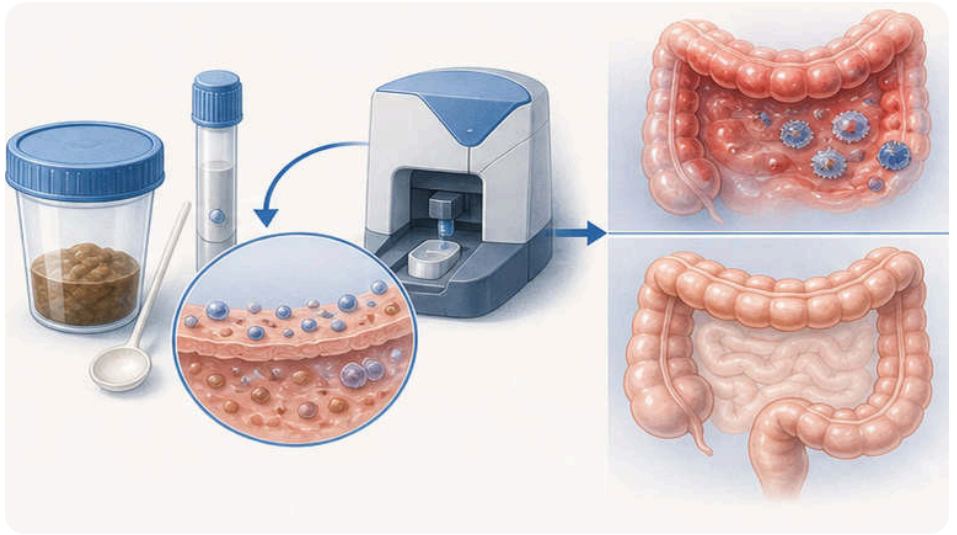


그림 · 대변 속 염증 물질을 재서 장 염증 여부를 가늠합니다(설명용 그림).

근거 · van Rheenen 2010 · 칼프로텍틴 감별 연구

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

이런 증상이 있으면 먼저 검사가 필요합니다

하나라도 있으면 과민성 장 증후군으로 보기 전에 대장암·염증성 장질환을 확인합니다

1

피가 섞이거나 검은 변 · 빈혈

설명되지 않는 출혈 신호는 대장암·염증성 장질환·궤양의 신호일 수 있습니다.

대장내시경

2

모르게 빠지는 체중

다이어트 없이 6개월 안에 몸무게가 5% 넘게 줄었다면 원인을 찾아야 합니다.

원인 검사

3

가족력 · 50세 이후 새 증상

대장암·염증성 장질환·셀리악병의 직계 가족력, 50세 넘어 새로 생긴 증상, 밤에 배가 아프거나 설사로 깨는 경우입니다.

추가 검사

Tip · 과민성 장 증후군은 대개 밤에 잠을 깨울 만큼 아프지 않습니다.

근거 · ACG 경고 증상 · 대한소화기기능성질환·운동학회

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

오늘 기억할 여섯 가지

생활습관 → 식단 → 약, 차례대로 함께 관리합니다

01 과민성 장 증후군은 꾀병이 아니라 **장과 뇌의 신호** 문제입니다

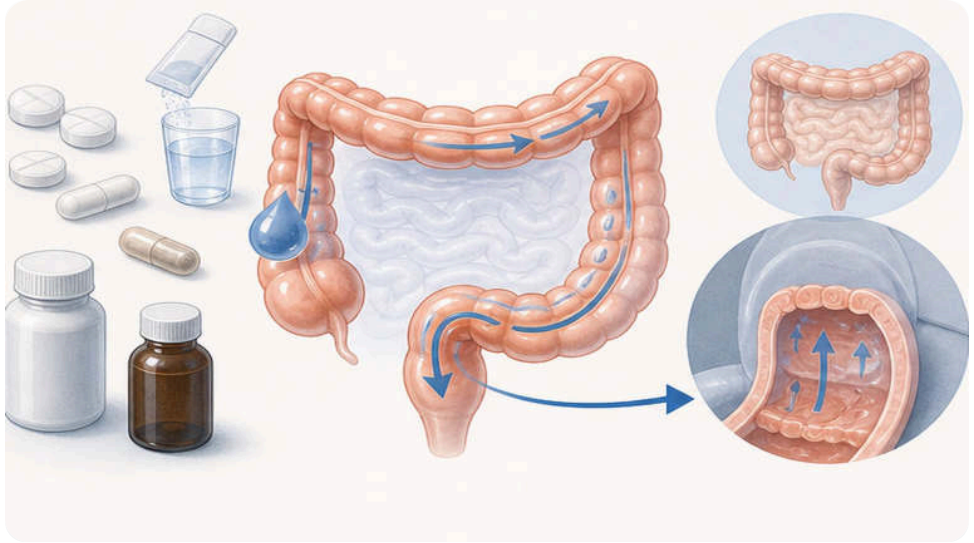
02 암이나 염증성 장질환으로 진행하지 않습니다

03 2주 동안 변 모양을 적어 **내 유형**을 알아 둡니다

04 저포드맵 식단은 **짧게** 시험하는 방법입니다

05 약은 유형과 증상에 맞춰 진료에서 고릅니다

06 피·체중 감소·가족력이 있으면 **먼저 검사**합니다



Tip · 증상 기록(언제·무엇을 먹고·변 모양)을 가져오시면 진료가 빨라집니다.

근거 · Rome IV · ACG 진료지침 2021

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

다시 보기 · 문의

QR로 다시 보기 · 음식 목록과 단계별 식단은 식사 안내문을 드립니다

광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

과민성 장 증후군을 이해하고 관리하는 방법을 안내하는 설명자료입니다. 검사와 약은 담당 의사와 상의해 정합니다.

참고한 자료

Rome IV(2016) · ACG 진료지침 2021 · Monash University 저포드맵 프로그램 · Mayer 2011 · van Rheenen 2010 · 브리스톨 대변 척도

SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서 같은 자료를 다시 볼 수 있어요